Etude de l'utilisation des utérotoniques dans la prise en charge de l'hémorragie du post-partum immédiat au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Nom du présentateur : NACANABO Zalihatou

Auteurs et coauteurs : NACANABO. Z, Dr Souleymane FOFANA, Pr Der Adolphe SOME

Affiliations : CHUSS, INSSA

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Hémorragie du Post Partum (HPP)
  - Principale cause de décès maternel dans le monde, plus 140 000 décès par an
- Utérotoniques
  - Efficaces dans la prévention et le traitement de l'HPP
  - Ocytocine, carbétocine, misoprostol, carboprost, méthylergométrine, ergométrine
- Etudier l'utilisation de ces utérotoniques dans la PEC de l'HPP

Objectif

Evaluer l'utilisation des utérotoniques dans la prévention/traitement de l'hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) dans le service d'obstétrique du Centre Hospitalier Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso selon leur conformité par rapport au guide national de prise en charge de l'HPP.

Matériel et méthode(s)

❑ Cadre, champ, site d'étude

- **Cadre :** CHUSS
- **Champ:** DGOMR
- **Site :** service d'obstétrique

❑ Type d'étude et période de collecte

- **Type :** étude transversale à collecte prospective
- **Période :** 15 février au 16 mars 2025

Matériel et méthode(s)

- **Population cible** →
  - Patiente bénéficiaire
  - Utérotoniques
  - Prévention/traitement HPP
- **Critère d'inclusion** →
  - Accouchée dans le service
  - Utérotoniques
  - Prévention/traitement HPPI
- **Echantillon et échantillonnage** →
  - **N =** 357 femmes
  - Recrutement consécutif

Matériel et méthode(s)

- **Méthode, techniques et instruments de collecte des données**

Méthode → Enquête

Techniques →
- Observation directe des pratiques
- Entretien individuel direct

Instrument → Fiche de collecte

Résultats

❑ caractéristiques sociodémographiques des parturientes

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage
Tranche d'âge (en années)	
< 20	8,12
20 – 35	**71,15**
≥ 35	20,73
Milieu de résidence	
Urbain	**74,79**
Rural	25,21
Situation matrimoniale	
Mariée	**92,44**
Célibataire/veuve	7,56
Occupation principale	
Femme occupée au foyer	**69,19**
Etudiante/ Elève	13,17
Commerçante	8,96
Autres*	8,68

Résultats

❑ Fréquence d'utilisation des utérotoniques dans le service d'obstétrique

➢ Répartition des parturientes selon l'utérotonique utilisé

Utérotonique utilisé	Effectif	Pourcentage
En prévention	357	100
Ocytocine seule	310	**86,83**
Ocytocine + Carboprost	27	7,56
Ocytocine + Misoprostol	18	5,04
Ocytocine + Misoprostol + Carboprost	2	0,56
En curatif	29	8,12
Misoprostol seul	10	**2,80**
Carboprost seul	5	1,40
Ocytocine + Carboprost	4	1,12
Ocytocine + Misoprostol	3	0,84
Misoprostol + Carboprost	3	0,84
Ocytocine seule	2	**0,56**
Ocytocine + Misoprostol + Carboprost	2	0,56

Résultats

- **Niveau d'application des directives thérapeutiques nationales en matière de prévention et de traitement de l'HPP**

Ocytocine seule:

- Indications: **CONFORMES**
- Voies
  - IM
  - IV

  CONFORMES
- Doses 20 UI en GATPA : **0,56 % NON CONFORME**

Résultats

- **Niveau d'application des directives thérapeutiques nationales en matière de prévention et de traitement de l'HPP**

Misoprostol

- En prévention chez 5,6 % des patientes: **NON CONFORME**
- Voies
  - Sublinguale: **5,04%**
  - Intra-rectale: **0,56 %**

  } **NON CONFORMES**
- Doses 800 µg en prévention: 16 cas **NON CONFORMES**

Résultats

- **Niveau d'application des directives thérapeutiques nationales en matière de prévention et de traitement de l'HPP**

Carboprost : **NON RECOMMANDE**

- Carboprost seul: **1,40 %** des cas
- Carboprost + ocytocine: **8,68 %** des cas
- Carboprost + misoprostol: **0,84 %** des cas
- Carboprost + misoprostol + ocytocine: **1,12 %** des cas

} **NON CONFORMES**

Conclusion

- L'HPP principale cause de décès maternels
- Comparant les pratiques réelles aux directives
- Utilisation variée des utérotoniques

Merci pour votre attention